

보건복지부 고시 제2025- 호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 따라 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 (보건복지부 고시 제2025-189호(2025. 11. 26.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2025년 12월 일

보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」 일부개정(안)

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

II. 약제 "[218] Cilostazol + Rosuvastatin 복합경구제(품명: 실로듀오서방정), [391] Maralixibat 경구제(품명: 리브말리엑(마라릭시벳염화물)), [396] Glucagon 주사제(품명: 글루카겐하이포키트주), [396] Glucagon외용제(품명: 바크시미나잘스프레이)"를 별지 1과 같이 신설하고, "[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준, [142] Dupilumab 주사제(품명: 듀피젠트프리필드주300밀리그램 등), [149] Omalizumab 주사제(품명: 졸레이주사 등), [229] Benralizumab 주사제(품명: 파센라프리필드시린지주30밀리그램), [229] Mepolizumab 주사제(품명: 누칼라주), [229] Reslizumab 주사제(품명: 싱케어주), [439] Anakinra(품명 : 키너렛주), [629] Levofloxacin 경구제(품명: 레보펙신정 등), [639] Eculizumab 주사제(품명: 솔리리스주 등), [639] Ravulizumab 주사제(품명: 울토미리스주 등)"의 세부 인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2026년 1월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[218] 동맥경화용제			
구 분	현 행	개 정(안)	사 유
[218] Cilostazol + Rosuvastatin 복합경구제 (품명: 실로듀오서방 정)	<신 설>	「Cilostazol 경구제」 및 [일반원칙] 고지혈증치료제 “세부사항” 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 - ○ 죽상동맥경화에 의한 만성동맥폐색증(폐색성 동맥경화증, 당뇨병성 말초혈관병증)으로 Rosuvastatin과 Cilostazol을 안정적으로 복용하고 있는 환자에서 전환하는 경우	○ Cilostazol + Rosuvastatin 복합경구제(품명: 실로듀오서방정)가 신규 등재예정임에 따라 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함
※ 관련근거 <요양급여 신규등재에 따른 급여기준 신설>			

[391] 간장질환용제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[391] Maralixibat 경구제 (품명: 리브말리엑(마라릭 시벳염화물))	<신 설>	○ 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 1) 알라질증후군(Alagille syndrome)으로 진단받은 생후 3개월 이상의 환자로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 가) 혈청 담즙산(sBA, serum bile acid) 농도가 100 μ mol/L 이상인 경우 나) CGIS 점수가 2점 이상인 중등도 이상의 소양증 ※ CGIS(Clinician Global Impression of Symptoms) 점수 환자 또는 간병인이 경험한 지난주의 가려움 정도와 내원 시 환자 진료결과(수면장애, 피부손상 등) 등을 종합적으로 반영한 임상양의 소양증 평가점수 [0점: 없음(None) 1점:약간(Mild), 2점: 보통(Moderate), 3점: 심각함(Severe), 4점: 매우 심각함(Very severe)] 2) 제외기준 투여 시작 또는 투여 중 다음의 조건 중 어느 하나라도 해당하는 경우 투여대상에서 제외함. - 다 음 - 가) 간 이식을 받은 경우	○ Maralixibat 경구제 (품명: 리브말리엑(마라릭시벳염화물))가 신규 등재 예정임에 따라, 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.

		나) 비대상성 간경변, 간 보상기전 상실(정맥류 출혈, 복수, 간성 뇌병증 등) 나. 평가방법 첫 투약 후 6개월에 평가 시 치료반응*을 만족하는 경우 추가 6개월의 투여를 인정함. 이후 매 6개월마다 평가하여 치료반응이 유지되면 지속적인 투여를 인정함. * 치료반응: 혈청 담즙산(sBA) 농도가 기저치 대비 30% 이상 감소한 경우. 다만, 혈청 담즙산(sBA) 농도가 기저치 대비 30% 이상 감소하지 않았더라도 소양증의 개선(평균 CGIS점수가 1점 이하 또는 기저치 대비 1점 이상 감소)이 있는 경우는 치료반응으로 간주함 ※ 평균 CGIS점수: 평가주기 당 매월 평가한 CGIS의 평균점수 다. 1회 처방 기간은 퇴원 및 외래의 경우 최대 30일분까지로, 병 단위 처방함, 다만, 허가용량에 따른 1병의 투여기간이 30일을 초과하는 경우, 1회 처방 용량은 최대 1병으로 함. ※ 허가사항 중 ‘사용 상 주의사항(보관 및 취급상의 주의 등)’ 을 반드시 참고하여 투여하여야 함. 라. 치료 반응 확인을 위해 매월 CGIS 평가를 시행하여야 함. 마. 동 약제는 간·담도 관련 치료 경험이 있는 관련분야 전문의가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(CGIS 결과, sBA 수치 검사결과, 임상적 진료기록지 등)를 반드시 제출하여야 함.	
--	--	---	--

		바. 동 약제의 사후관리를 위한 절차·방법 및 위원회 구성 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정하고, 동 약제의 고시 적용에 있어 의학적 판단이 필요한 사항은 건강보험심사평가원장이 정하는 위원회 결정에 따름.	
※ 관련근거 · 리브말리엑 의약품 품목허가보고서 · EMA(First Published: 2022.12.14., Last updated: 2024.7.12.) · FDA(Initial Approval: 2021, Revised: 2024.11.8.) · Nelson Text book of pediatrics Chapter 404: Cholestasis (2024) · Dermatology 6. Pruritus and Dysesthesia (2024) · EASL Clinical Practice Guidelines on genetic cholestatic liver diseases (2024) · Gonzales E et al. Efficacy and safety of maralixibat treatment inpatients with Alagille syndrome and cholestaticpruritus (ICONIC): a randomised phase 2 study. Lancet. 2021 Oct 30;398(10311):1581–1592. · Benjamin L. Shneider et al Impact of long-term administration of maralixibat on children with cholestasis secondary to Alagille syndrome Hepatol Commun. 2022;6(8):1922–1933. · Impact of long-term administration of maralixibat on children with cholestasis secondary to Alagille syndrome Hepatol Commun. 2022;6(8):1922–1933. · Event-free survival of maralixibat-treated patients with Alagille syndrome compared to a real-world cohort from GALA Hepatology. 2024;79:1279–1292 · 대한소화기학회(대소학 2023-123, 2023.10.17.) · 대한소아소화기영양학회(소소영 2023-37, 2023.10.23.) · 대한소아청소년학회&대한소아소화기영양학회 (대소학 2025-346호, 2025.4.17.) · CADTH Reimbursement Recommendation (24.9.20) · NICE: In progress (Expected publication 24 June 2024)			

[396] 당뇨병용제			
구 분	현 행	개 정(안)	사유
[396] Glucagon 주사제 (품명: 글루카겐하이포 키트주)	<신 설>	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 ‘당뇨병을 가진 소아·성인의 중증 저혈당증’에 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위 1. 치료목적 사용 당뇨병을 가진 소아·성인의 중증 저혈당증 치료 2. 진단목적 사용 성인의 위장관 운동 억제(검사 진단보조)	○ 긴급도입의약품인 ‘글루카겐하이포키트주’가 등재예정임에 따라 급여 기준을 신설함. 다만, 식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 ‘치료목적으로 당뇨병을 가진 소아·성인의 중증 저혈당증’으로 제한함
※ 관련근거 · Goldman-Cecil Medicine 27e. 2024 · Harrison’s Principles of Internal Medicine, 21e. 2022. · ADA(American Diabetes Association), 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes—2025. · AACE(American Association of Clinical Endocrinology), Clinical Practice Guideline: Developing a Diabetes Mellitus Comprehensive Care Plan—2022 Update. · 대한당뇨병학회, 당뇨병 진료지침 제8판. 2023. · ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Assessment and management of hypoglycemia in children and adolescents with diabetes. · Andrew collier et al. comparison of Intravenous Glucagon and Dextrose in Treatment of Severe Hypoglycemia in an Accident and Emergency			

[396] 당뇨병용제

구 분	현 행	개 정(안)	사 유
	Department. Diabetes Care 10:712-15, 1987.		
	· MA. W. PATRICK et al. Comparison of intramuscular glucagon and intravenous dextrose in the treatment of hypoglycaemic coma in an accident and emergency department. Archives of Emergency Medicine, 1990, 7, 73-77.		
	· Michael R. Rickels et al. Intranasal Glucagon for Treatment of Insulin-Induced Hypoglycemia in Adults With Type 1 Diabetes: A Randomized Crossover Noninferiority Study. Diabetes Care 2016;39:264-270.		
	· Thomas R. Pieber et al. Dasiglucagon-A Next-Generation Glucagon Analog for Rapid and Effective Treatment of Severe Hypoglycemia: Results of Phase 3 Randomized Double-Blind Clinical Trial. Diabetes Care 2021;44:1361-1367.		
	· Tadej Battelino et al. Dasiglucagon, a next-generation ready-to-use glucagon analog, for treatment of severe hypoglycemia in children and adolescents with type 1 diabetes: Results of a phase 3, randomized controlled trial. Pediatr Diabetes. 2021;22:734-741.		
	· Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 11e. 2020		
	· ESGAR/ESPR(European Society of Gastrointestinal Abdominal Radiology/European Society of Paediatric Radiology), The first joint ESGAR/ESPR consensus statement on the technical performance of cross-sectional small bowel and colonic imaging(2016)		
	· ACR/SAR(American College of Radiology/Society of Abdominal Radiology), ACR-SAR-SPR PRACTICE PARAMETER FOR THE PERFORMANCE OF COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) ENTEROGRAPHY (2015)		
	· Abhilash Perisetti et al. Clinical safety and outcomes of glucagon use during endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), Endosc Int Open 2022; 10: E558-E561		
	· Anupam Aditi et al. Glucagon Shortens Cecal Intubation Time and Total Procedure Time During Colonoscopy: A Prospective, Double-Blind Placebo Controlled Randomized Trial, Biomed J Sci & Tech Res 22(2)-2019; 16467-16472		

[396] 당뇨병용제			
구 분	현 행	개 정(안)	사 유
[396] Glucagon 외용제 (품명: 바크시미 나잘스프레이)	<신 설>	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 투여 시 영양급여를 인정함. ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위: 4세 이상 당뇨 환자에서 발생한 심각한 저혈당증	○ 긴급도입의약품인 ‘바크시미나잘스프레이’가 신규 등재 예정임에 따라 급여기준을 신설함
※ 관련근거 · Goldman-Cecil Medicine 27e. 2024 · Harrison’s Principles of Internal Medicine, 21e. 2022. · ADA(American Diabetes Association), 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes – 2025. · AACE(American Association of Clinical Endocrinology), Clinical Practice Guideline: Developing a Diabetes Mellitus Comprehensive Care Plan – 2022 Update. · 대한당뇨병학회, 당뇨병 진료지침 제8판. 2023. · ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2022: Assessment and management of hypoglycemia in children and adolescents with diabetes. · Marga G, Kamlesh K et al. Systematic Literature Review and Indirect Treatment Comparison of Three Ready-to-Use Glucagon Treatments for Severe Hypoglycemia. Diabetes Therapy (2023) 14:1757–1769 · Jeffrey G. et al. Glucagon Administration by Nasal and Intramuscular Routes in Adults With Type 1 Diabetes During Insulin-Induced Hypoglycaemia: A Randomised, Open-Label, Crossover Study. Diabetes Therapy (2020) 11:1591–1603 · Michael R. Rickels et al. Intranasal Glucagon for Treatment of Insulin-Induced Hypoglycemia in Adults With Type 1 Diabetes: A Randomized Crossover Noninferiority Study. Diabetes Care 2016;39:264–270. · Jennifer L. et al. Glucagon Nasal Powder: A Promising Alternative to Intramuscular Glucagon in Youth With Type 1 Diabetes, Diabetes Care 2016;39:555–562			

[별지 2]

[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)		사유																																		
	현 행	개 정(안)																																			
[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준	고가의약품 중 아래의 약제를 투여한 경우 관리기간 동안 환자의 투약 및 평가정보를 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서 서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용 명세서에 기재하여 제출하여야 함. 또한, 성과평가 등을 위한 방법·절차 등의 세부 사항은 건강보험심사평가원장이 정함. - 아 래 - <table> <tr> <th>약제명</th> <th>관리 기간</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td>김리아주(Tisag enlecleucel)</td> <td>1년</td> <td>비호지킨림프종에 투여한 경우</td> </tr> <tr> <td>줄겐스마주(Onas emnogene abeparvovec)</td> <td>5년</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>스핀라자주 (Nusinersen sodium)</td> <td>1년</td> <td rowspan="2">첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우</td> </tr> <tr> <td>에브리스디건조 시럽(Risdiplam)</td> <td>1년</td> </tr> <tr> <td>렉스터나주 (Voretigene neparvovec)</td> <td>4년</td> <td>-</td> </tr> </table>	약제명	관리 기간	비고	김리아주(Tisag enlecleucel)	1년	비호지킨림프종에 투여한 경우	줄겐스마주(Onas emnogene abeparvovec)	5년	-	스핀라자주 (Nusinersen sodium)	1년	첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우	에브리스디건조 시럽(Risdiplam)	1년	렉스터나주 (Voretigene neparvovec)	4년	-	고가의약품 중 아래의 약제를 투여한 경우 관리기간 동안 환자의 투약 및 평가정보를 「요양급여비용 청구방법, 심사청구서·명세서 서식 및 작성요령」에 따라 요양급여비용 명세서에 기재하여 제출하여야 함. 또한, 성과평가 등을 위한 방법·절차 등의 세부 사항은 건강보험심사평가원장이 정함. - 아 래 - <table> <tr> <th>약제명</th> <th>관리 기간</th> <th>비고</th> </tr> <tr> <td>김리아주(Tisag enlecleucel)</td> <td>1년</td> <td>비호지킨림프종에 투여한 경우</td> </tr> <tr> <td>줄겐스마주(Onas emnogene abeparvovec)</td> <td>5년</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>스핀라자주 (Nusinersen sodium)</td> <td>1년</td> <td rowspan="2">첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우</td> </tr> <tr> <td>에브리스디건조 시럽(Risdiplam)</td> <td>1년</td> </tr> <tr> <td>렉스터나주 (Voretigene neparvovec)</td> <td>4년</td> <td>-</td> </tr> </table>	약제명	관리 기간	비고	김리아주(Tisag enlecleucel)	1년	비호지킨림프종에 투여한 경우	줄겐스마주(Onas emnogene abeparvovec)	5년	-	스핀라자주 (Nusinersen sodium)	1년	첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우	에브리스디건조 시럽(Risdiplam)	1년	렉스터나주 (Voretigene neparvovec)	4년	-	○ 리브말리액 신규 등재에 따른 일반원 칙 변경
약제명	관리 기간	비고																																			
김리아주(Tisag enlecleucel)	1년	비호지킨림프종에 투여한 경우																																			
줄겐스마주(Onas emnogene abeparvovec)	5년	-																																			
스핀라자주 (Nusinersen sodium)	1년	첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우																																			
에브리스디건조 시럽(Risdiplam)	1년																																				
렉스터나주 (Voretigene neparvovec)	4년	-																																			
약제명	관리 기간	비고																																			
김리아주(Tisag enlecleucel)	1년	비호지킨림프종에 투여한 경우																																			
줄겐스마주(Onas emnogene abeparvovec)	5년	-																																			
스핀라자주 (Nusinersen sodium)	1년	첫 투여 시 만18세 초과이면서, HFMSE 점수가 5점 미만인 환자에 투여한 경우																																			
에브리스디건조 시럽(Risdiplam)	1년																																				
렉스터나주 (Voretigene neparvovec)	4년	-																																			

[일반원칙] 고가의약품 급여관리에 관한 기준

구 분	세부인정기준 및 방법 개정(안)						사유
	현 행			개 정(안)			
	과지바주 (Dinutuximab beta)	3년	고위험군에 투여한 경우	과지바주 (Dinutuximab beta)	3년	고위험군에 투여한 경우	
		2년	재발성·불응성에 투여한 경우		2년	재발성·불응성에 투여한 경우	
	빌베이캡슐 (Odevixibat)	1년	-	빌베이캡슐 (Odevixibat)	1년	-	
	<신 설>			리브말리엑 (Maralixibat)	5년	-	

[142] 자격료법제(비특이성 면역원제포함), [149] 기타의 알레르기용약, [229] 기타의 호흡기관용약

구 분	현 행	개 정(안)	사유
	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
[142] Dupilumab 주사제 (품명: 듀피젠트 프리필드주 300밀리그램 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담 토록 함. - 아 래 -	각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인 정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 -	○ 교과서, 가이드라인 임상 논문, 학회 (전문가) 의견 등을 참조하여 성인(만 18세 이상) 및 청소년 (만 12세-만 17세)의 중

	<u><신 설></u> 가. 투여대상 (생 략) 나. 평가방법 (생 략) 다. 교체투여 (생 략) 라. 원내처방을 원칙으로 하며, 퇴원 시 및 외래에서의 1회 처방기간은 최대 4주 분까지로 함. - 단, 최초 투약일로부터 24주 이후에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우에는 최대 8~12주분까지 인정함. 마. 동 약제는 자가주사제인 점을 고려하여, 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고, 요양기관이 이를 관리하여야 함. 바. 동 약제는 아토피 관련 진료과(피부과, 알레르기내과, 소아알레르기호흡기)) 전문의가 처방하여야 하며, 최초 투여 시 투여대상 및 지속투여 시 반응평가에 대한 객관적 자료(약제투여 과거력, EASI 산출근거, 환자 사진 등)를 반드시 제출하여야 함. <u><신 설></u>	<u>1. 만성 중증 아토피피부염</u> 가. 투여대상 (현행과 같음) 나. 평가방법 (현행과 같음) 다. 교체투여 (현행과 같음) 라. (현행과 같음) 마. (현행과 같음) 바. (현행과 같음) <u>2. 중증 제2형 염증성 천식</u> <u>가. 투여대상</u>	중 제2형 염증성 천식 환자에 급여 신설
--	--	---	-------------------------------

		성인(만 18세 이상) 및 청소년(만 12세 - 만 17세)의 중증 제2형 염증성 천식(중증 호산구성 천식 또는 경구 코르티코스테로이드 의존성 중증 천식) 환자 중 고용량의 흡입용 코르티코스테로이드-장기지속형 흡입용 베타2 작용제(ICS-LABA)와 장기지속형 무스카린 길항제(LAMA)의 투여에도 불구하고 적절하게 조절이 되지 않는 경우로서 다음 1), 2) 조건 중 하나에 해당하는 경우 ※ ICS-LABA: Inhaled CorticoSteroids-Long Acting Beta-2 Agonist LAMA: Long Acting Muscarinic Antagonist - 다 음 - 1) 치료 시작 전 12개월 이내에 혈중 호산구 수치가 $150 \text{ cells}/\mu\text{l}$ 이상 또는 호기산화질소(FeNO)가 25 ppb 이상이면서 치료 시작 전 12개월 이내에 전신 코르티코스테로이드가 요구되는 천식 급성악화가 4번 이상 발생한 경우 2) 치료 시작 6개월 전부터 prednisolone 5mg/day 이상과 동등한 수준의 경구 코르티코스테로이드를 지속적으로 투여한 경우(단, 듀피젠트프리필드주300mg 및 듀피젠트프리필드펜300mg에 한함.)	
--	--	---	--

		<u>나. 평가방법</u> <u>동 약제 투여 전과 투여 후 매 1년마다(경구 코르티코스테로이드 의존성 천식의 경우 매 6개월마다) 평가하여 다음 중 한 가지 이상을 만족하면서, 전반적인 천식조절을 확인한 환자에 대한 투여소견서 제출 시 지속 투여를 인정함.</u> <u>(단, 임상증상 등을 고려하여 효과가 불충분하다고 판단되는 경우에는 1년 이내이더라도 치료 효과를 평가할 수 있음.)</u> <u>- 다 음 -</u> <u>1) 천식 급성 악화의 빈도가 치료 시작 전 대비 50% 이상 감소</u> <u>2) 지속적인 경구 코르티코스테로이드 치료가 필요한 환자의 경우 천식증상 조절을 개선하거나 유지하면서 경구 코르티코스테로이드 용량이 치료 시작 전 대비 50% 이상 감소</u> <u>다. 병용투여</u> <u>중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제 (omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, dupilumab)간 병용투여는 급여 인정하지 아니함.</u> <u>라. 교체투여</u>	
--	--	---	--

		1) <u>중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(mepolizumab, reslizumab, benralizumab, dupilumab)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함.</u> 2) <u>omalizumab 주사제 투여 후 동 약제로의 교체투여는 다음의 조건을 모두 만족하면서 투여소견서 첨부 시 사례별로 급여 인정함.</u> <u>- 다 음 -</u> <u>가) omalizumab 주사제를 3~6개월 이상 사용하였음에도 효과가 불충분하거나 부작용으로 투약을 지속할 수 없는 경우 또는 복약순응도 개선의 필요성이 있는 경우</u> <u>나) 동 약제의 투여대상 조건 1), 2)를 만족하는 경우</u>	
[149] Omalizumab 주사제 (품명 : 줄레이주사 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 알레르기성 천식 1) 투여대상 (생 략) 2) 평가방법 (생 략) 3) 중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 알레르기성 천식 1) 투여대상 (현행과 같음) 2) 평가방법 (현행과 같음) 3) 중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제	○ 중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제인 ‘Dupilumab 주사제(품명: 듀피젠트프리필드주300밀리그램 등)’가 급여 확대 예정임에 따라, 병용

	(omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, <추 가>)간 병용투여는 급여 인정하지 아니함. 4) 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(mepolizumab, reslizumab, benralizumab, <추 가>)에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함.	(omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, <u>dupilumab</u>)간 병용투여는 급여 인정하지 아니함. 4) 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(mepolizumab, reslizumab, benralizumab, <u>dupilumab</u>)에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함.	투여 및 교 체 투여 기준에 해당 성분명을 추가함.
[229] Benralizumab 주사제 (품명: 파센라 프리필드시린지주30밀리그램)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. 투여대상 (생 략) 2. 평가방법 (생 략) 3. 중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(omalizumab, mepolizumab, benralizumab, reslizumab, <추 가>)간 병용투여는 급여 인정하지 아니함. 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(mepolizumab, benralizumab, reslizumab, <추 가>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함. 나. (생 략)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. 투여대상 (현행과 같음) 2. 평가방법 (현행과 같음) 3. 중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(omalizumab, mepolizumab, benralizumab, reslizumab, <u>dupilumab</u>)간 병용투여는 급여 인정하지 아니함. 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(mepolizumab, benralizumab, reslizumab, <u>dupilumab</u>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함. 나. (현행과 같음)	

[229] mepolizumab 주사제 (품명: 누칼라주)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. 투여대상 (생 략) 2. 평가방법 (생 략) 3. 중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제 (omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, <추 가>)간 병용투여는 급여 인정하지 아니함. 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학 적 제제(mepolizumab, reslizumab, benralizumab, <추 가>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투 여는 인정하지 아니함. 나. (생 략)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. 투여대상 (현행과 같음) 2. 평가방법 (현행과 같음) 3. 중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제 (omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab, <u>dupilumab</u>)간 병용투여는 급여 인정하지 아니함. 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학 적 제제(mepolizumab, reslizumab, benralizumab, <u>dupilumab</u>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체 투여는 인정하지 아니함. 나. (현행과 같음)	
[229] Reslizumab 주사제 (품명: 싱케어주)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. 투여대상 (생 략) 2. 평가방법 (생 략) 3. 중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제 (omalizumab, mepolizumab, reslizumab,	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 1. 투여대상 (현행과 같음) 2. 평가방법 (현행과 같음) 3. 중증 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제 (omalizumab, mepolizumab, reslizumab,	

	benralizumab, <추 가>)간 병용투여는 급여 인정하지 아니함. 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(mepolizumab, reslizumab, benralizumab, <추 가>)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함. 나. (생 략)	benralizumab, dupilumab)간 병용투여는 급여 인정하지 아니함. 4. 교체투여 가. 중증 호산구성 천식 환자에 사용하는 생물학적 제제(mepolizumab, reslizumab, benralizumab, dupilumab)간 교체투여 및 동 약제에서 omalizumab으로의 교체투여는 인정하지 아니함. 나. (현행과 같음)	
--	---	--	--

※ 관련근거

1. 한국 천식진료지침 2021, 대한천식알레르기학회
2. 천식진료지침 2022 5차 개정, 대한결핵 및 호흡기학회
3. GINA Guidelines (2024), Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2023 Update)
4. Lee E, et al. Increasing prevalence and mortality of asthma with age in Korea, 2002–2015: a nationwide, population-based study. Allergy Asthma Immunol Res 2020;12(3):467–84.
5. Shim, Ji-Su, et al. "Clinical predictors of treatment response to tiotropium add-on therapy in adult asthmatic patients: From multicenter real-world cohort data in Korea." World Allergy Organization Journal 15.12 (2022): 100720.
6. Wang E, Wechsler ME, Tran TN, Heaney LG, Jones RC, Menzies-Gow AN, et al. Characterization of severe asthma worldwide: data from the International Severe Asthma Registry. Chest 2020;157(4):790–804.
7. Kim et al, Characteristics of Adult Severe Refractory Asthma in Korea Analyzed From the Severe Asthma Registry. Allergy Asthma Immunology Research. 2019;11(1):e10.
8. Rhee, Chin Kook, et al. "Effect of dupilumab in Korean patients with uncontrolled moderate-to-severe asthma: a LIBERTY ASTHMA QUEST sub-analysis." Allergy Asthma Immunology Research 2022 Mar;14(2):182–195
9. Hong et al, Cost-Effectiveness of Tiotropium in Elderly Patients with Severe Asthma Using Real-World Data. The Journal of Allergy and

Clinical Immunology: In Practice. 2021;9(5):1939-1947.e7

10. Kim, Sang-Heon, et al. "Perceptions of severe asthma and asthma-COPD overlap syndrome among specialists: a questionnaire survey." Allergy Asthma Immunology Research 10.3 (2018): 225-235.
11. Wechsler et al. Long-term safety and efficacy of dupilumab in patients with moderate-to-severe asthma (TRAVERSE): an open-label extension study. Lancet Respir Med 2022;10:11-25.
12. M. Castro, et al. Dupilumab Efficacy and Safety in Moderate to-Severe Uncontrolled Asthma. N Engl J Med 2018;378:2486-96.
13. Klaus et al. Efficacy and Safety of Dupilumab in Glucocorticoid-Dependent Severe Asthma. N Engl J Med 2018;378:2475-85.
14. Wechsler et al. "Dupilumab long-term safety and efficacy in patients with asthma: LIBERTY ASTHMA TRAVERSE." Presented at the 30th International Congress of the European Respiratory Society (ERS); Virtual Congress; September. Vol. 7. 2020.
15. Akenroye et al. "Comparative efficacy of mepolizumab, benralizumab, and dupilumab in eosinophilic asthma: A Bayesian network meta-analysis." Journal of Allergy and Clinical Immunology 150.5 (2022): 1097-1105.
16. Tohda et al. "Cost-effectiveness analysis of dupilumab among patients with oral corticosteroid-dependent uncontrolled severe asthma in Japan." Journal of Asthma 59.11 (2022): 2162-2173.
17. Rabe et al. Efficacy and safety of dupilumab in glucocorticoid-dependent severe asthma. N Engl J Med 2018;378:2475-85.
18. Akenroye et al. Comparative effectiveness of omalizumab, mepolizumab, and dupilumab in asthma: A target trial emulation. J Allergy Clin Immunol 2023;151:1269-76.
19. 의약품 품목허가 보고서_듀피젠트프리필드펜200밀리그램 (2021)
20. 의약품 품목허가 보고서_듀피젠트프리필드펜300밀리그램 (2021)

[439] 기타의 조직세포의 치료 및 진단

구 분	현 행	개 정(안)	사유
-----	-----	--------	----

	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
[439] Anakinra (품명 : 키너렛주)	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 투여 시 요양급여를 인정함. ※ 식품의약품안전처장이 인정한 범위: 다음에 해당하는 류마티스(자가염증질환) 증상의 경감 ○ 만성 유아 신경 피부 및 관절 증후군(CINCA; Chronic Infantile Neurologic Cutaneous and Articular Syndrome)으로 확정된 환자	식품의약품안전처장이 인정한 범위 내에서 <u>아래와 같은 기준으로</u> 투여 시 요양급여를 <u>인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함.</u> <u>- 아 래 -</u> ○ 만성 유아 신경 피부 및 관절 증후군(CINCA; Chronic Infantile Neurologic Cutaneous and Articular Syndrome)으로 확정된 환자 <u>의 류마티스(자가염증질환) 증상의 경감</u> ※ <u>식품의약품안전처장이 인정한 범위</u> ○ <u>다음에 해당하는 류마티스(자가염증질환) 증상의 경감</u> <u>- 만성 유아 신경 피부 및 관절 증후군(CINCA; Chronic Infantile Neurologic Cutaneous and Articular Syndrome)으로 확정된 환자</u> ○ <u>CAR-T 세포 치료 후 발생가능한 사이토카인방출 증후군(CRS), 신경독성증후군(ICANS), 혈구탐식성 림프조직구증(IEC-HLH) 치료</u> ○ <u>슈니츨러증후군(Schnitzler syndrome) 치료</u>	○ 식품의약품안전처장이 인정한 긴급도입 의약품 인정 범위 변경과 관련하여 급여인정범위를 명확히 함.
※ 관련근거			

[629] 기타의 화학요법제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[629] Levofloxacin 경구제 (품명: 레보펙신정 등)	1. 허가사항 범위 내에서 1차 약제 투여로 증상이 호전되지 않는 환자에게 투여하는 것을 원칙으로 하며, 아래와 같은 경우에는 1차 약제로 투여 시에도 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. 타 항생제에 내성이 있는 환자, 면역기능이 저하된 환자, 중증 감염환자, 심부 장기감염환자(예: 폐렴, 급성 신우신염) 나. 중증 폐렴환자의 경우는 β -Lactam과 병용하여 투여 시에도 인정함. 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 -	1. 허가사항 범위 내에서 1차 약제 투여로 증상이 호전되지 않는 환자에게 투여하는 것을 원칙으로 하며, 아래와 같은 경우에는 1차 약제로 투여 시에도 요양급여를 인정함. - 아 래 - 가. 타 항생제에 내성이 있는 환자, 면역기능이 저하된 환자, 중증 감염환자, 심부 장기감염환자(예: 폐렴, 급성 신우신염) 나. 중증 폐렴환자의 경우는 β -Lactam과 병용하여 투여 시에도 인정함. 2. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정함. - 아 래 -	○ 교과서 가이드라인 임상 연구문헌, 전문가 의견 등을 고려하여, 다제내성 또는 리팜핀 내성 결핵환자의 접촉자의 잠복결핵 감염의 치료관련 급여 기준을 확대하고 체계자구를 수정함

[629] 기타의 화학요법제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	가. 결핵 환자 중 다음의 경우<추 가> - 다 음 - 1) isoniazid 또는 rifampicin에 내성균이 확인된 결핵 2) 균이 확인되지 않았더라도 3-6개월 투여 후 임상이가 치료실패로 적절히 판단하는 경우(투여소견서 첨부) 3) 부작용으로 인해 기존 결핵약제의 계속적인 투여가 곤란한 경우 4) 약물 상호작용이 우려되어 기존 결핵약제(리팜핀 등)의 투여가 곤란한 경우 <u><추 가></u> 나. 헬리코박터 파일로리(H.pylori) 감염이 확인된 다음의 환자에서 3차 제균요법으로 10~14일간 투여한 경우 - 다 음 -	가. 결핵 환자 중 다음의 경우(소아·성인) - 다 음 - 1) isoniazid 또는 rifampicin에 내성균이 확인된 결핵 2) 균이 확인되지 않았더라도 3-6개월 투여 후 임상이가 치료실패로 적절히 판단하는 경우(투여소견서 첨부) 3) 부작용으로 인해 기존 결핵약제의 계속적인 투여가 곤란한 경우 4) 약물 상호작용이 우려되어 기존 결핵약제(리팜핀 등)의 투여가 곤란한 경우 <u>나. 잠복결핵감염의 치료(소아·성인)</u> <u>1) 투여대상: 다제내성(isoniazid 와 rifampicin), rifampicin 내성균이 확인된 결핵환자의 접촉자</u> <u>2) 투여기간: 6개월</u> 다. (현행과 같음)	

[629] 기타의 화학요법제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	1) 소화성궤양 2) 저등급 MALT(Mucosa Associated Lymphoid Tissue) 림프종 3) 조기 위암 절제술 후 4) 특발성 혈소판 감소성 자반증(idiopathic thrombocytopenic purpura) 5) 위선종의 내시경절제술 후 <u>다.</u> 마크로라이드 불응성 마이코플라스마 폐렴 1) 투여대상: 마크로라이드계 항생제 투여 3일 후에도 증상이 개선되지 않는 소아 2) 용법용량 ○ 5세 미만: 16~20 mg/kg/일, 2회 분복 (최대 750mg/일) ○ 5세 이상: 8~10 mg/kg/일, 1일 1회 (최대 750mg/일) ○ 근골격계 성숙이 이루어진 청소년: 500 mg/일, 1일 1회 3) 투여기간: 7~14일 이내 ※ 허가사항 중 사용상의 주의사항을 고려하여	<u>라.</u> (현행과 같음) <이 동>	

[629] 기타의 화학요법제

구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
	<u>임상적 유용성이 위험성보다 높은 경우에 한하여, 근골격계 등 이상반응에 대하여 환자(보호자)에게 충분히 설명 및 동의 후 사용</u> 3. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (이하 생략)	3. 허가사항 범위를 초과하여 아래와 같은 기준으로 투여 시 약값 전액을 환자가 부담토록 함. (현행과 같음) 4. <u>허가사항 중 사용상의 주의사항을 고려하여 소아에게 투여시 임상적 유용성이 위험성보다 높은 경우에 한하여, 근골격계 등 이상반응에 대하여 환자(보호자)에게 충분히 설명 및 동의 후 사용.</u>	

※ 관련근거

- Harrison's Principles of Internal Medicine, 22e, 2022/updated 2025.
- Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 14th, 2023.
- 결핵진료지침 5판, 2024.
- 국가 결핵관리지침, 2025.
- WHO, consolidated guidelines on tuberculosis, Module 1: Prevention Tuberculosis preventive treatment, 2024.
- Hesseling A.C. et al. Levofloxacin Preventive Treatment in Children Exposed to MDR Tuberculosis[TB CHAMP], N Engl J Med 2024;391:2315-26.
- Greg J. Fox et al. Levofloxacin for the Prevention of Multidrug-Resistant Tuberculosis in Vietnam,[V-QUIN MDR-TB] N

[629] 기타의 화학요법제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
Engl J Med 2024;391:2304-14. • Trinh Duong et al, A Meta-Analysis of Levofloxacin for Contacts of Multidrug-Resistant Tuberculosis, 2024, NEJM Evid 2025;4(1). • NICE, Tuberculosis(NG33), 2024. • CADTH, Treatment of Tuberculosis: A Review of Guidelines, 2020.			

[639] 기타의 생물학적 제제			
구 분	현 행	개 정(안)	사유
	세부인정기준 및 방법	세부인정기준 및 방법	
[639] Eculizumab 주사제 (품명: 솔리리스주 등)	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준을 모두 만족하는 경우 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 발작성 야간 혈색소뇨증 (PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) (생 략) 나. 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS: atypical	1. 각 약제별 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준을 모두 만족하는 경우 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS: atypical	○ 비정형 용혈성 요독 증후군에 Eculizumab 주사제 일반심사 전환에 따라 사전심사 관련 기준 변경 및 혈액검사 등 기준 명확화

	Hemolytic Uremic Syndrome) <추 가> 1) 투여대상 다음의 가)~라)를 모두 만족하거나, 마)에 해당하는 비정형 용혈성 요독 증후군인 경우 - 다 음 - 가) 다음 (1)~(5) 중 (1)을 포함하여 3개 이상을 만족하는 활성화형 혈전미세혈관병증 (TMA: Thrombotic Microangiopathy) (1) 혈소판수: $150 \times 10^9/L$ 미만 (2) 분열적혈구(schistocytes): 검출 (3) 헤모글로빈: 12g/dL 미만 (5세 미만 소아 11g/dL 미만) (4) 젖산탈수소효소(LDH: Lactate dehydrogenase): 정상 상한치 이상 (5) 합토클로빈(haptoglobin): 정상 하한치 미만 나) 다음에 해당되는 신장손상 (1) 기존의 신장기능이 저하된 경우 eGFR 20% 이상 감소 (2) 기존의 신장기능이 정상인 경우: 혈청 크레아티닌이 연령 및 성별에 따른 정상 상한치 이상	Hemolytic Uremic Syndrome) (최초 투여 시 [붙임 1] 제출) 1) 투여대상 다음의 가)~라)를 모두 만족하거나, 마)에 해당하는 비정형 용혈성 요독 증후군인 경우 - 다 음 - 가) ~ 나) (현행과 같음)	
--	---	--	--

	다) ADAMTS- 13 활성 결과: 10% 이상 (1) 검사 시기는 혈장교환술 또는 혈장주입술을 시행하기 전, 4회 실시 이전, 중단 7일 이후 시행한 경우 (2) ADAMTS-13 활성 결과 확인 전 혈소판 수 $30 \times 10^9/L$ 이상인 경우 에는 사전 <u>신청서 제출 후 투여 가능 <삭 제></u> (3) ADAMTS-13 활성 결과 10% 미만인 경우 이후 투여 분부터는 불인정 라) 대변 STEC(Shiga toxin-producing E.Coli) 결과 음성 마) 비정형 용혈성 요독 증후군으로 인한 말기 신부전이 의심되어 신장이식 전후에 동 약제 투여가 필요한 경우 사례별로 인정함. 2) 제외대상: 다음과 같은 원인으로 인한 혈전미세혈관병증(TMA) 가) 활동성 악성종양 나) 활동성 HIV 감염 다) 약물*로 인한 혈전미세혈관병증(TMA)이 발생한 경우 * 약물: 항암제, 면역억제제, 퀴닌, 고용량의 칼시뉴린 저해제, 항혈소판제제,	다) ADAMTS- 13 활성 결과: 10% 이상 (1) 검사 시기는 혈장교환술 또는 혈장주입술을 시행하기 전, 4회 실시 이전, 중단 7일 이후 시행한 경우 (2) ADAMTS-13 활성 결과 확인 전 혈소판 수 $30 \times 10^9/L$ 이상인 경우 (3) ADAMTS-13 활성 결과 10% 미만인 경우 이후 투여 분부터는 불인정 라) ~ 마) (현행과 같음) 2) (현행과 같음)	
--	--	---	--

	sirolimus, anti-VEGF agents 등 라) 활동성 자가면역질환으로 인한 혈관염 마) 파종성혈관내응고증 3) 치료효과 평가 <u><추 가></u> 가) 초기 모니터링 자료(치료 시작 후 2개월 에 제출, 단 각 항목에 따른 검사 미제출 시에는 사유 기재) (1) 2개월간의 <u>전혈구검사(CBC), 혈소판, 젖산탈수소효소(LDH), 합토글로빈 (haptoglobin), 망상적혈구(reticulocyte) 수치</u> (2) <u><추 가></u> 혈청 크레아티닌, 사구체여과 율(eGFR) (3) <u>보체 관련 항체검사 결과</u> (4) 유전자검사 결과 (5) 수막구균 백신 접종 확인 <u>증명서</u> (6) 지난 2개월 동안의 수혈 현황 (7) 가족력 (8) 최근 임상 병력 (9) 혈전미세혈관병증으로 인한 다음의 기관 손상 유무 확인 ○ 신경계 손상, 심장 손상, 소화기계 손상, 폐 손상 등	3) 치료효과 평가 (모니터링 [붙임 2] 제출) 가) 초기 모니터링 자료(치료 시작 후 2개월 에 제출, 단 각 항목에 따른 검사 미제출 시에는 사유 기재) (1) 2개월간의 <u>혈소판수, 분열적혈구 (schistocytes), 헤모글로빈, 젖산탈수소 효소(LDH), 합토글로빈(haptoglobin), 망상적혈구(reticulocyte) 수치</u> (2) <u>요소질소(BUN)</u>, 혈청 크레아티닌, 사구 체여과율(eGFR) (3) <u>보체 및 관련 항체검사 결과</u> (4) (현행과 같음) (5) 수막구균 백신 접종 확인 <u>접종내역</u> (6) ~ (9) (현행과 같음)	
--	--	---	--

나) 유지기 모니터링 자료(치료 시작 후 매 6개월마다 모니터링 하여 투여유지 여부를 평가함)<삭 제> (1) 6개월간의 <u>전혈구검사(CBC), 혈소판, 젖산탈수소효소(LDH), 합토글로빈(haptoglobin), 망상적혈구(reticulocyte) 수치</u> (2) <추 가> 혈청 크레아티닌, 사구체여과율(eGFR) (3) 지난 6개월 동안의 수혈 현황 (4) 최근 임상 병력 다) 투여 유지 기준 (1) 효과 평가 (가) 혈소판수, 분열적혈구, 헤모글로빈, 합토글로빈(haptoglobin), LDH 5개 중 3가지 이상의 정상화 (나) 다음에 해당하는 신장기능 개선 ○ 투여 직전 측정한 eGFR 보다 25%를 초과한 호전 ○ 신장기능이 악화 되지 않은 경우(투여 직전 측정한 eGFR $\pm$ 25%)	나) 유지기 모니터링 자료(치료 시작 후 매 6개월마다 모니터링) (1) 6개월간의 <u>혈소판수, 분열적혈구(schistocytes), 헤모글로빈, 젖산탈수소효소(LDH), 합토글로빈(haptoglobin), 망상적혈구(reticulocyte) 수치</u> (2) <u>요소질소(BUN), 혈청 크레아티닌, 사구체여과율(eGFR)</u> (3) ~ (4) (현행과 같음) 다) 투여 유지 기준 (1) (현행과 같음)
--	---

	(2) 투여기간(지속투여) (가) 다음의 경우 2년간 지속 투여를 인정하며, <u>추가 투여가 필요한 경우 매회 실시한 모니터링에 대한 심의결과에 따라 인정함.</u> - 다 음 - 1) 동 약제 투여가 필요한 유전자 변이 (pathogenic/likely pathogenic variant)가 있는 경우 2) 재발할 가능성이 높은 경우(이전에 재발하였거나 가족력이 있는 경우, 10세 미만 소아, 비정형 용혈 요독 증후군으로 말기신부전이 발생한 신장이식 전후에 치료가 필요한 경우) (나) 유전자 변이가 없거나 확인되지 않은 환자의 <u>지속투여는 매회 실시한 모니터링에 대한 심의결과에 따라 인정함.</u> 라) 투여 중단 기준 (1) 신장투석을 유지하면서, 신장 이외 합병증이 개선되지 않는 경우 (2) 치료효과를 평가하기 위한 6개월 간격 모니터링 자료를 제출하지 않은 경우 (3) 의학적 정당한 이유 없이 동 약제투여를 6개월에 3회 이상 누락된 경우(단 의료진	(2) 투여기간(지속투여) (가) 다음의 경우 2년간 지속 투여를 인정하며, <u>추가 투여가 필요한 경우 매회 실시한 모니터링 결과에 따라 인정함.</u> - 다 음 - 1) ~ 2) (현행과 같음) (나) 유전자 변이가 없거나 확인되지 않은 경우의 지속투여는 <u>매회 실시한 모니터링 결과에 따라 인정함.</u> 라) 투여 중단 기준 (1) ~ (4) (현행과 같음)	
--	---	---	--

	의 판단에 따른 경우 객관적 근거를 제출 하여야 함.) (4) 상기 ‘다) 투여유지기준 (1) 효과평가’ 결과에 따라 중지하는 경우 (가) 혈액학적 수치 정상화와 신장기능 개선 모두 만족하지 못한 경우 (나) 혈액학적 수치 정상화와 신장기능 개선 모두 만족하여 6개월 동안 결과가 지속된 경우 마) 재투여 기준 급여기준에 해당되어 동 약제를 투여 한 이후 재발되어 재투여가 필요한 경우 사전신청서 (ADAMTS-13, STEC 결과 생략 가능) 제출 후 즉시 투여 가능함< 삭 제 > 4) 실시기관 등 ○ 혈장교환술을 실시하는 요양기관에서 요양 급여 인정여부에 대하여 사전 신청 후 승인 받은 경우에 한하여 인정함. 단, 사전신청서 제출 후 즉시 투여하는 경우(ADAMTS-13 결과 확인 전 또는 재투여 기준에 따라 투여 시) 심의 결과 통보 전까지 투여분을 요양급여함.< 삭 제 > 다. (생 략)	마) 재투여 기준 급여기준에 해당되어 동 약제를 투여 한 이후 재발된 경우 투여 가능 <u>4) 실시기관</u> ○ 혈장교환술을 실시하는 요양기관 다. (현행과 같음)	
--	---	--	--

	2. (생 략) 3. Eculizumab 주사제의 사전심사 방법·절차 및 위원회 구성, 사전심사 운영 기간 등에 대한 세부사항은 건강보험심사평가원장이 정함, (단, 가. 발작성 야간 혈색소뇨증과 다. 시신경 척수염 범주질환(NMOSD)의 경우, 사전승인 심사 대상에 해당되지 않음.) <삭 제>	2. (현행과 같음)	
[639] Ravulizumab 주사제 (품명: 울토미리스주 등)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 발작성 야간 혈색소뇨증(PNH: Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria) (생 략) 나. 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS: atypical Hemolytic Uremic Syndrome) <추 가> 1) 투여대상 다음의 가)~라)를 모두 만족하거나, 마)에 해당하는 비정형 용혈성 요독 증후군인 경우 - 다 음 - 가) 다음 (1)~(5) 중 (1)을 포함하여 3개 이상을 만족하는 활성형 혈전미세혈관병증	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. 비정형 용혈성 요독 증후군(aHUS: atypical Hemolytic Uremic Syndrome) (최초 투여시 [붙임 1] 제출) 1) 투여대상 다음의 가)~라)를 모두 만족하거나, 마)에 해당하는 비정형 용혈성 요독 증후군인 경우 - 다 음 - 가)~나) (현행과 같음)	○ 비정형 용혈성 요독 증후군에 Ravulizumab 주사제 일반심사 전환에 따라 사전심사 관련 기준 변경 및 혈액검사 등 기준 명확화

	(TMA: Thrombotic Microangiopathy) (1) 혈소판수: $150 \times 10^9/L$ 미만 (2) 분열적혈구(schistocytes): 검출 (3) 헤모글로빈: 12g/dL 미만 (5세 미만 소아 11g/dL 미만) (4) 젖산탈수소효소(LDH: Lactate dehydrogenase): 정상 상한치 이상 (5) 합토클로빈(haptoglobin): 정상 하한치 미만 나) 다음에 해당되는 신장손상 (1) 기존의 신장기능이 저하된 경우 eGFR 20% 이상 감소 (2) 기존의 신장기능이 정상인 경우: 혈청 크레아티닌이 연령 및 성별에 따른 정상 상한치 이상 다) ADAMTS- 13 활성 결과: 10% 이상 (1) 검사 시기는 혈장교환술 또는 혈장주입술을 시행하기 전, 4회 실시 이전, 중단 7일 이후 시행한 경우 (2) ADAMTS-13 활성 결과 확인 전 혈소판수 $30 \times 10^9/L$ 이상인 경우 에는 사전신청서 제출 후 투여 가능<삭 제> (3) ADAMTS-13 활성 결과 10% 미만인		
		다) ADAMTS- 13 활성 결과: 10% 이상 (1) 검사 시기는 혈장교환술 또는 혈장주입술을 시행하기 전, 4회 실시 이전, 중단 7일 이후 시행한 경우 (2) ADAMTS-13 활성 결과 확인 전 혈소판수 $30 \times 10^9/L$ 이상인 경우 (3) ADAMTS-13 활성 결과 10% 미만인 경우 이후 투여 분부터는 불인정	

	경우 이후 투여 분부터는 불인정 라) 대변 STEC(Shiga toxin-producing E.Coli) 결과 음성 마) 비정형 용혈성 요독 증후군으로 인한 말기 신부전이 의심되어 신장이식 전후에 동 약제 투여가 필요한 경우 사례별로 인정함. 2) 제외대상: 다음과 같은 원인으로 인한 혈전미세혈관병증(TMA) 가) 활동성 악성종양 나) 활동성 HIV 감염 다) 약물*로 인한 혈전미세혈관병증(TMA)이 발생한 경우 * 약물: 항암제, 면역억제제, 퀴닌, 고용량의 칼시뉴린 저해제, 항혈소판제제, sirolimus, anti-VEGF agents 등 라) 활동성 자가면역질환으로 인한 혈관염 마) 파종성혈관내응고증 바) 임신 및 산후 3개월 이내 3) 치료효과 평가 <추 가> 가) 초기 모니터링 자료(치료 시작 후 2개월	라)~마) (현행과 같음) 2) (현행과 같음) 3) 치료효과 평가 (모니터링 [붙임 2] 제출) 가) 초기 모니터링 자료(치료 시작 후 2개월에 제출, 단 각 항목에 따른 검사 미제출	
--	---	---	--

	에 제출, 단 각 항목에 따른 검사 미제출 시에는 사유 기재) (1) 2개월간의 전혈구검사(CBC), 혈소판, 젖산탈수소효소(LDH), 합토글로빈(haptoglobin), 망상적혈구(reticulocyte) 수치 (2) <추 가> 혈청 크레아티닌, 사구체여과율(eGFR) (3) 보체 관련 항체검사 결과 (4) 유전자검사 결과 (5) 수막구균 백신 접종 확인 증명서 (6) 지난 2개월 동안의 수혈 현황 (7) 가족력 (8) 최근 임상 병력 (9) 혈전미세혈관병증으로 인한 다음의 기관 손상 유무 확인 ○ 신경계 손상, 심장 손상, 소화기계 손상, 폐 손상 등 나) 유지기 모니터링 자료(치료 시작 후 매 6개월마다 모니터링 하여 투여유지 여부를 평가함)<삭제> (1) 6개월간의 전혈구검사(CBC), 혈소판, 젖산탈수소효소(LDH), 합토글로빈(haptoglobin), 망상적혈구(reticulocyte)	시에는 사유 기재) (1) 2개월간의 <u>혈소판수</u>, <u>분열적혈구(schistocytes)</u>, <u>헤모글로빈</u>, <u>젖산탈수소효소(LDH)</u>, <u>합토글로빈(haptoglobin)</u>, <u>망상적혈구(reticulocyte) 수치</u> (2) <u>요소질소(BUN)</u>, <u>혈청 크레아티닌</u>, <u>사구체여과율(eGFR)</u> (3) <u>보체 및 관련 항체검사 결과</u> (4) (현행과 같음) (5) 수막구균 백신 접종 확인 <u>접종내역</u> (6)~(9) (현행과 같음) 나) 유지기 모니터링 자료(치료 시작 후 매 6개월마다 모니터링) (1) 6개월간의 <u>혈소판수</u>, <u>분열적혈구(schistocytes)</u>, <u>헤모글로빈</u>, <u>젖산탈수소효소(LDH)</u>, <u>합토글로빈(haptoglobin)</u>, <u>망상적혈구(reticulocyte) 수치</u>	
--	---	--	--

	수치 (2) <추 가> 혈청 크레아티닌, 사구체여과율(eGFR) (3) 지난 6개월 동안의 수혈 현황 (4) 최근 임상 병력 다) 투여 유지 기준 (1) 효과 평가 (가) 혈소판수, 분열적혈구, 헤모글로빈, 합토클로빈(haptoglobin), LDH 5개 중 3가지 이상의 정상화 (나) 다음에 해당하는 신장기능 개선 ○ 투여 직전 측정한 eGFR 보다 25%를 초과한 호전 ○ 신장기능이 악화 되지 않은 경우(투여 직전 측정한 eGFR $\pm$ 25%) (2) 투여기간(지속투여) (가) 다음의 경우 2년간 지속 투여를 인정하며, 추가 투여가 필요한 경우 매회 실시한 모니터링에 대한 심의결과에 따라 인정함. - 다 음 - 1) 동 약제 투여가 필요한 유전자 변이(pathogenic/likely pathogenic variant)가	(2) <u>요소질소(BUN), 혈청 크레아티닌, 사구체여과율(eGFR)</u> (3)~(4) (현행과 같음) 다) 투여 유지 기준 (1) (현행과 같음) (2) 투여기간(지속투여) (가) 다음의 경우 2년간 지속 투여를 인정하며, <u>추가 투여가 필요한 경우 매회 실시한 모니터링 결과에 따라 인정함.</u> - 다 음 - 1) (현행과 같음)	
--	--	--	--

	있는 경우 2) 재발할 가능성이 높은 경우(이전에 재발하였거나 가족력이 있는 경우, 10세 미만 소아, 비정형 용혈 요독 증후군으로 말기신부전이 발생한 신장이식 전 후에 치료가 필요한 경우) (나) 유전자 변이가 없거나 확인되지 않은 환자의 지속투여는 <u>매회 실시한 모니터링에 대한 심의결과에 따라 인정함.</u> 라) 투여 중단 기준 (1) 신장투석을 유지하면서,, 신장 이외 합병증이 개선되지 않는 경우 (2) 치료효과를 평가하기 위한 6개월 간격 모니터링 자료를 제출하지 않은 경우 (3) 의학적 정당한 이유 없이 동 약제 투여를 6개월에 1회 이상 누락된 경우(단 의료진의 판단에 따른 경우 객관적 근거를 제출하여야 함.) (4) 상기 ‘다) 투여유지기준 (1) 효과평가’ 결과에 따라 중지하는 경우 (가) 혈액학적 수치 정상화와 신장기능 개선 모두 만족하지 못한 경우 (나) 혈액학적 수치 정상화와 신장기능 개선 모두 만족하여 6개월 동안 결과가 지속된 경우	2) (현행과 같음) (나) 유전자 변이가 없거나 확인되지 않은 경우의 지속투여는 <u>매회 실시한 모니터링 결과에 따라 인정함.</u> 라) 투여 중단 기준 (1) ~ (4) (현행과 같음) 마) 재투여 기준	
--	---	--	--

	마) 재투여 기준 급여기준에 해당되어 동 약제를 투여 한 이후 재발되어 재투여가 필요한 경우 <u>사전신청서 (ADAMIS-13, STEC 결과 생략 가능) 제출 후 즉시 투여 가능함< 삭제 ></u> 바) 교체투여 기준 Eculizumab 주사제를 6개월 이상 투여중인 환자로 투여 유지 기준에 해당하는 경우 4) 실시기관 등 ○ 혈장교환술을 실시하는 요양기관에서 <u>요양급여 인정여부에 대하여 사전 신청 후 승인 받은 경우에 한하여 인정함.</u> <u>단, 사전신청서 제출 후 즉시 투여하는 경우(ADAMIS-13 결과 확인 전 또는 재투여 기준에 따라 투여 시) 심의 결과 통보 전까지 투여분을 요양급여함.< 삭제 ></u> 2. 율토미리스주는 중대한 수막구균 (Meningococcus) 감염에 대한 감수성을 증가시키므로 모든 환자가 투약 최소 2주전에 수막구균 백신을 투여 받아야 하며 최신의 백신 접종지침에 따라 재접종해야 함. 단, 율토미리스주를 즉시 투여해야 하는 경우 수막구균 백신을 동시에 투여하며 항생제치료를	급여기준에 해당되어 동 약제를 투여 한 이후 재발된 경우 투여 가능 바) 교체투여 기준 Eculizumab 주사제를 6개월 이상 투여중인 환자로 투여 유지 기준에 해당하는 경우 4) 실시기관 ○ 혈장교환술을 실시하는 요양기관 2. (현행과 같음)	
--	---	---	--

	병행할 수 있음. 3. 울토마리스주의 사전심사 방법·절차 및 위원회 구성, 사전심사 운영 기간 등에 대한 세부 사항은 건강보험심사평가원장이 정함. (단, 가. 발작성 야간 혈색소뇨증의 경우, 사전 승인 심사 대상에 해당되지 않음.) <삭 제>		
※ 관련근거 · 진료심사평가위원회(위원회심사부) 요청에 따라, aHUS 관련 약제 일반심사 전환에 따른 급여기준 변경 검토보고(‘25.11.25., 약제기준부)			

[붙임1]

솔리리스주 등(성분명: Eculizumab) · 울토미리스주 등(성분명: Ravulizumab) 관련 진료내역

(앞쪽)

1. aHUS 최초 진단일		년	월	일					
2. TMA 발현 시점일		년	월	일					
3. 약제 투여 시작일		년	월	일					
4. 활성형 미세혈관병증 유 ☐ 무 ☐									
구분	참고치	TMA 발현 시점			aHUS 진단 시점			약제 투여 시점	
		검사일:	년	월	일	검사일:	년	월	일
혈소판수(PLT)	-								
분열적혈구	-								
헤모글로빈(Hb)	-								
LDH	(~)								
Haptoglobin	(~)								
망상적혈구(%)	-								
BUN	-								
Cr	-								
eGFR	-								
5. 신장 손상 유 ☐ 무 ☐		1) eGFR 수치비교			기 존 수 치 : () ,		검 사 일 : ()		
					현 재 수 치 : () ,		검 사 일 : ()		
					참 고 치 (~)				
		2) 혈청 크레아티닌 수치비교			기 존 수 치 : () ,		검 사 일 : ()		
					현 재 수 치 : () ,		검 사 일 : ()		
					참 고 치 (~) 연령 및 성별에 따른 정상 상한치 입력				
3) 투석내역 (기간, 횟수)									
6. ADAMTS-13		검사일: () ,			결 과 값 () %				
		검사시기			혈장교환술 또는 혈장주입술 ☐ 시행 전 ☐ 4회 실시 이전 ☐ 중단 7일 이후				
		ADAMTS-13 결과 확인 전일 경우			검사일: () 혈소판수: () * 10 ⁹ /L				
7. STEC (Shiga toxin-producing E.Coli)		☐ ① 양성 ☐ ② 음성			검사일: ()				
8. aHUS로 인한 말기신부전 의심 유 ☐ 무 ☐		신장이식			☐ 이식 전		이식예정일 ()		
					☐ 이식 후		이식일 ()		
9. Coomb's test		☐ ① 양성 ☐ ② 음성			검사일: ()				
10. 수혈력 및 혈장교환술		1) 수혈력 (기간, 단위)							
		2) 혈장교환술 (기간, 횟수)							

210mm×297mm[백상지 (80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

11. aHUS 가족력	☐ ① 유 (환자와의 관계:) ☐ ② 무		
12. 유전자 검사 결과	검사일: 년 월 일		
	결 과:		
13. 수막구균 백신 접종	접종유무	☐ ① 유 ☐ ② 무	
	접종일	()	
	접종관련 내용		
14. 제외대상	1) 활동성 악성종양	☐ ① 유 ☐ ② 무	
	2) 활동성 HIV 감염	☐ ① 유 ☐ ② 무	
	3) 약물*로 인한 혈전미세혈관병증(TMA)이 발생한 경우 * 약물: 항암제, 면역억제제, 퀴닌, 고용량의 칼시뉴린 저해제, 항혈소판제제, sirolimus, anti-VEGF agents 등	☐ ① 유 ☐ ② 무	
	4) 활동성 자가면역질환으로 인한 혈관염	☐ ① 유 ☐ ② 무	
	5) 파종성혈관내응고증	☐ ① 유 ☐ ② 무	
	6) 임신 및 산후 3개월 이내 ※ 대상약제 Ravulizumab인 경우 작성	☐ ① 유 ☐ ② 무 출산일 혹은 출산예정일: (년 월 일)	
◎ 제외대상 관련 제출자료: 악성종양 이력, HIV 검사, 자가면역질환 검사, DIC 검사, 투약기록지, 관련 영상검사 및 진료기록지 등			
15. 보체 및 관련 항체 검사결과(시행한 경우)	☐ 유 ☐ 무	검사일:	결과값
16. 신장 조직검사 결과(시행한 경우)	☐ 유 ☐ 무	검사일:	결과값
17. 기타 소견			

첨부서류	1. 'aHUS로 인한 말기신부전 의심' 을 확인 할 수 있는 자료 2. (자료 요청시) 진료내역 기재 사항을 입증할 수 있는 모든 검사결과지 및 진료 기록 3. (보완 요청 시) 보완자료 * 진료내역과 첨부 자료의 내용이 일치하여야 함
------	---

[붙임2]

솔리리스주 등(성분명: Eculizumab) · 울토미리스주 등 (성분명: Ravulizumab) 관련 진료내역(2개월·매 6개월)

(앞쪽)

1. 최초 투여일자 및 자료제출 기간	년 월 일로부터 ☐ 2개월 ☐ 매 6개월 (총 투여 기간 년 개월)	
2. 대상약제 투여용량 등	대상약제	☐ ① Eculizumab ☐ ② Ravulizumab
	1회 용량	☐ ① 첫 투여 ☐ ② 유지
	투여일	
	투여중단/변경사유	
	교체투여 여부	☐ 유 (Eculizumab 투여일 년 월 일) ☐ 무
3. 모니터링 필수 자료 ① 제출자료: (검사수치) PLT, 분혈적혈구, Hb, LDH, haptoglobin, 망상적혈구(%), BUN, Cr, eGFR - (2개월 모니터링) 투여 전, 투여 후 2개월간 검사수치 - (6개월 모니터링) 최근 6개월간 검사수치 ② 검사수치 기재 방법 - (2개월 모니터링) 최초투여 전, 4주째, 8주째 - (6개월 모니터링) 최초투여 전, 이전 차수(2개월 모니터링 자료 또는 6개월 전 모니터링 자료), 현재 자료		

구분	참고치	최초 투여 전	이전 차수 (2개월 모니터링 시 4주째)	현재 차수 (2개월 모니터링 시 8주째)
		검사일: 년 월 일	검사일: 년 월 일	검사일: 년 월 일
혈소판수(PLT)	-			
분열적혈구	-			
헤모글로빈(Hb)	-			
LDH	(~)			
Haptoglobin	(~)			
망상적혈구(%)	-			
BUN	-			
Cr	-			
eGFR	-			

4. 수혈력, 혈장교환술 및 투석내역 -(2개월 모니터링) 최근 2개월간 -(6개월 모니터링) 최근 6개월간	1) 수혈력 (기간, 단위) 2) 혈장교환술 (기간, 횟수) 3) 투석내역 (기간, 횟수)	
5. 유전자 검사 결과 (2개월 자료)	검사일: 년 월 일	
	결 과:	
6. 보체 및 관련 항체 검사 결과 (2개월 자료)		

7. 혈전미세혈관병증으로 인한 기관 손상	신경계 손상 ☐ ① 유 ☐ ② 무	심장 손상 ☐ ① 유 ☐ ② 무	소화기계 손상 ☐ ① 유 ☐ ② 무	폐 손상 ☐ ① 유 ☐ ② 무
8. 기타 소견				

필수 첨부서류	1. (자료 요청시) 진료내역 기재 사항을 입증할 수 있는 모든 검사결과지 및 진료 기록 단, 각 항목에 따른 검사 미제출시 사유를 기재하도록 함. 2. (보완 요청시) 보완자료 * 진료내역과 첨부 자료의 내용이 일치하여야 함
---------	---